

«Шигельоз»

1. Завдання, що виконуються здобувачем освіти на станції:

- Виміряти артеріальний тиск за методом Короткова.
- Оцінити клінічний аналіз крові.
- Оцінити результат дослідження копроцитограми.
- Оцінити бактеріологічне дослідження випорожнень.
- Встановити попередній діагноз.
- Визначити тактику ведення та лікування пацієнта.
- Означити рекомендації щодо профілактики та пропаганди здорового способу життя.

2. Клінічні кейси (сценарії, задачі), які відпрацьовуються на станції з пакетами додаткових матеріалів:

- Сценарій «Діагностика та подальша тактика ведення і лікування хворого з діагнозом шигельоз».

Ви – лікар приймального відділення. До Вас звернувся чоловік 42 років, водій.

Скарги: на підвищення температури тіла до 39,2°C, часті (до 20 р/добу) випорожнення з домішками слизу та крові, біль у нижніх відділах живота, особливо у лівій здухвинній ділянці, головний біль, виражену загальну слабкість, сухість у роті.

Анамнез захворювання: захворів 1 день тому, коли раптово температура тіла підвищилася до 39,6°C, з'явилося дворазове блювання, спастичні болі в верхніх, а потім – нижніх відділах живота, посилюються при дефекації, часті рідкі випорожнення. Самостійно приймав парацетамол, активоване вугілля. Напередодні захворювання їв сир зі сметаною домашнього виробництва. Наступного ранку стан не покращився, помітив слиз та кров у випорожненнях, звернувся до лікаря.

Об'єктивно: стан середньої тяжкості. Шкіра гіперемована, суха, гаряча на дотик, висипка відсутня. ЧДР 20 за хв. Тони серця приглушені, ритмічні. ЧСС=Пс=106 за хв., АТ – 110/70 мм рт.ст. У легенях – везикулярне дихання. Живіт м'який, болісний у лівій здухвинній ділянці, сигмоподібна кишка спазмована. Ознаки подразнення очеревини негативні. Печінка та селезінка не збільшені не пальпуються. Випорожнення 20 разів на добу, з домішками крові та слизу, сечовипускання без особливостей.

- Додаток 1. Клінічний аналіз крові.

Показник, що досліджується	Показник хворого	Норма	
		Чоловіки	Жінки
Еритроцити	3,2 x10 ¹² /л	4,0-5,1x10 ¹² /л	3,7-4,7x10 ¹² /л
Гемоглобін	118 г/л	130-160 г/л	120-140 г/л
Колірний показник	1,0	0,86-1,05	
Гематокрит	44 %	38-49 %	33-45 %
Тромбоцити	213 x10 ⁹ /л	180-320x10 ⁹ /л	
Кількість лейкоцитів	14,2 x10 ⁹ /л	4,0-8,8x10 ⁹ /л	
Лейкоцитарна формула:			
- мієлоцити	0	відсутні	
- метамієлоцити	0	відсутні	
- нейтрофіли:			

паличкоядерні	11 %	0,04-0,300x10 ⁹ /л (1-6 %)	
сегментоядерні	72 %	2,0-5,5x10 ⁹ /л (45-70 %)	
- еозинофіли	0 %	0,02-0,3x10 ⁹ /л (0-5 %)	
- базофіли	0	0-0,065x10 ⁹ /л (0-1 %)	
- лімфоцити	13 %	1,2-3,0x10 ⁹ /л (18-40 %)	
- моноцити	4 %	0,09-0,6x10 ⁹ /л (2-9 %)	
плазматичні клітки	0	відсутні	
ШОЕ, мм/год	23 мм/год	1-10	2-15

- Додаток 2. Копроцитограма.

Показник, що досліджується	Показник хворого	Норма
Кількість випорожнень	100	50-250 гр.
Форма	неоформлені	оформлені
Консистенція	рідкі	м'які
Колір	червоно-коричневий	жовтий, коричневий
Слиз	на все поле зору	відсутній
Лейкоцити	½ поля зору	1-2 екз. у полі зору
Еритроцити	на все поле зору	відсутні
Епітеліальні клітини	¼ поля зору	0-2 екз. у полі зору
Найпростіші	відсутні	відсутні
Яйця глистів	відсутні	відсутні

- Додаток 3. Бактеріологічне дослідження випорожнень.

Показник, що досліджується	Показник хворого	Норма
Наявність росту бактерій	<i>Sh. Sonnei</i> 10 ⁸	відсутній

3. Інформація для студента – алгоритм роботи на станції:

Ви зібрали скарги, анамнез захворювання та життя, провели об'єктивне обстеження:

Алгоритм дій здобувача.

	<i>Дії здобувача освіти</i>
1.ІНШЕ (В Т.Ч. ЛЕГАЛЬНІ ТА ЕТИЧНІ АСПЕКТИ):	
	інформовану згоду отримано; руки та мембрану фонендоскопу оброблено на гігієнічному рівні.
2.ВИКОНАННЯ НАВИЧКИ «ВИМІРЮВАННЯ АРТЕРІАЛЬНОГО ТИСКУ МЕТОДОМ КОРОТКОВА»	
	Коректно (на рівні серця) розташувати руки пацієнта та

	перевірити манометр	
	Коректне (на оголене плече, нижній край манжети розташувати на 2-3 см вище за ліктьовий згин) накладання манжети	
	Коректно (центр ліктьової ямки) розташувати акустичну голівку фонендоскопа	
	Накачати повітря у манжетку	
	При стравлюванні повітря з манжетки зафіксувати рівень систолічного (поява першого тону Короткова) та діастолічного (зникнення тонів Короткова) артеріального тиску	
	Зняття манжети	
	Самопочуття пацієнта задовільне	
3. ДІАГНОСТИКА:		Зняття ма
<i>Оцінити клінічний аналіз крові.</i> (Додаток 1)	Нейтрофільний лейкоцитоз. Зсув лейкоцитарної формули вліво. Прискорена ШОЕ - ознаки бактеріальної інфекції	
<i>Оцінити результат дослідження копроцитограми</i> (Додаток 2)	Рідкі неоформлені випорожнення, наявність патологічних домішок (слиз та кров на все поле зору, гній) - ознаки ентероколіту, гемоколіту.	
<i>Оцінити бактеріологічне дослідження випорожнень</i> (Додаток 3)	Наявність росту <i>Sh. Sonnei</i> свідчить про наявність бактеріального захворювання шигельоз	
<i>Встановити попередній діагноз:</i>	Гострий шигельоз, гастроентероколітичний варіант	
4. ВИЗНАЧЕННЯ ТАКТИКИ ВЕДЕННЯ ТА ЛІКУВАННЯ		
<i>Призначено наступні ліки:</i>	Антибактеріальні препарати (ципрофлоксацин) Спазмолітичні препарати Оральна регідрація (глюкосолан, ораліт) Жарознижуючі препарати Пробіотики	
5. Профілактика та пропаганда здорового способу життя:		
	Забруднений одяг, простирадла та ковдри слід замочувати у	

	закритій посудини з милом, водою та дезінфікуючим засобом, доки їх не можна буде випрати в гарячій воді. Для пацієнтів слід використовувати відповідні методи ізоляції та дезінфекції виділень (калу).
--	--